RESUMEN VISUAL · PARCIAL · MÓDULOS 3 Y 4

# Ciencias de la Ocupación

Todas las lecturas de los módulos 3 y 4: la CO hoy, la cultura y la ocupación, las AVD como instrumento de evaluación, la ocupación en el desarrollo humano, las teorías (proposiciones y supuestos), CO-OP, el abordaje orientado a la tarea, los modelos ecológicos, el MOHO, la adaptación ocupacional y la epistemología. Con cuadros, casos y un simulacro de 30 preguntas con respuestas explicadas.

DEFINICIÓN · EJEMPLO / CASO · CLAVE DE EXAMEN · ATENCIÓN · NO CONFUNDIR · REPASO RÁPIDO

**LO QUE TRAÉS DE M1 Y M2**

La **CO** (disciplina académica, ciencia social básica) estudia al ser humano como **ser ocupacional**: **forma, función y significado** de la ocupación. Nutre a la **TO** (profesión). Wilcock (1993): 3 propósitos de la ocupación. Kielhofner: volición, habituación y desempeño.

**EL HILO DE ESTOS MÓDULOS**

**M3**: cómo se aplica la CO en la TO de hoy (cultura, evaluación de AVD, desarrollo humano). **M4**: con qué **teorías y modelos** se piensa la intervención (CO-OP, tarea, ecológicos, MOHO, adaptación) y desde qué **epistemología**.

## U1 La CO y sus aportes contemporáneos a la ocupación

**LA OCUPACIÓN HOY**

Las ocupaciones son **procesos dinámicos** en los que interviene la **cultura**, que les asigna significado. También las determinan **creencias, valores, emociones** y el **sustrato neurobiológico** (base de las habilidades). Tanto el transcurso como el producto tienen un **potencial de crecimiento personal y de transformación** del contexto y del orden sociocultural.

**WILCOCK (1998)**

La ocupación es una síntesis de **ser, hacer y llegar a ser**.

### CO ⇄ TO

La CO se **retroalimenta** de la TO: ofrece una gama de posibilidades que fortalecen la base práctica de la TO, ajustadas a cada intervención y a las demandas personales y culturales.

### En salud mental

Estructura el conocimiento de la ocupación: define lo que promueve la **participación e integración social**, involucra a las personas en ocupaciones que sostienen su participación y su **salud** en la vida cotidiana (Da Silva Araújo et al.).

### Dimensión ocupacional

Se presenta como **ontología**, más allá de la descripción técnica: una vía para **modificarse a uno mismo y al mundo**, desde el cuidado y el compromiso con el otro. Es **individual y colectiva**: expresión cultural, política y social de cada época.

### Ocupación como promotora de salud

Hay que mirar los mecanismos que determinan las **oportunidades y elecciones ocupacionales** de las poblaciones para que puedan involucrarse en actividades con significado, bienestar y capacidad de contribuir a su comunidad.

**DERECHOS OCUPACIONALES**

Hoy son un **principio fundamental** de la práctica del TO: pueden contribuir a **reducir los determinantes sociales** que afectan la salud y el desempeño ocupacional en un plano **colectivo**.

### 1.1 ¿Por qué el estudio de la ocupación es una ciencia?

### La ciencia

Es la **búsqueda de patrones** (o su uso crítico) en la naturaleza o la sociedad. Se complica al fundamentar una ciencia **básica y aplicada**, como la CO.

### Qué estudia la CO

**Patrones de comportamiento humano** en la complejidad de la ocupación de personas, grupos o comunidades: cómo se desarrolla una ocupación, su **función** y su **significado**. Estudia a los humanos como **seres ocupacionales**, su necesidad y capacidad de **adaptación**.

### Objetivos

Generar una base sistemática de **descripción y comprensión** de la participación en ocupaciones para dar el **conocimiento básico que apoye la práctica aplicada** de la TO.

**PREMISA DE LA CO**

El conocimiento de la **forma, la función y el significado** de las ocupaciones, dentro y fuera de los contextos terapéuticos, permite comprender al hombre como un **"sujeto ocupacional"**.

**LA OCUPACIÓN ES CULTURAL**

Los elementos ocupacionales están revestidos de un **profundo sentido cultural**: los patrones responden a una **estructura aprendida**, y una misma actividad puede tener un **significado distinto** según la cultura en la que ocurre.

## U2 Influencia de los aspectos socioculturales en la CO

Cultura y ocupación se **retroalimentan** y se modifican mutuamente; los cambios entre culturas repercuten en la profesión. **Sociedad**: conjunto de personas que viven de una determinada manera e interactúan entre sí y con el medio; comprender al individuo es comprender a fondo su **unidad sociocultural**.

**CULTURA (GEERTZ, 1989)**

"Un **sistema de concepciones heredadas** expresado en **formas simbólicas** por medio de las cuales las personas se comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y actitudes hacia la vida."

**LA CULTURA SE INTERNALIZA**

Los **valores**, el sentido de **competencia**, los **intereses**, **roles y hábitos** reflejan la pertenencia a una cultura. Influye en lo que hay en el ambiente y en **cómo cada uno está predispuesto a interactuar** con él. Cada cultura ofrece una gama de ocupaciones (**oportunidades y demandas**) con **coherencia interna**: acciones conectadas a su significado y propósito (Corral Bergantiños et al., 2010).

**Ocupación: "las cosas que ordinariamente las personas llevan a cabo cada día, en cualquiera de los ámbitos de su vida". Sus dimensiones:**

- El **desempeño** del acto.
- El **contexto** en que se desempeñó.
- Las dimensiones **psicológicas**: necesidad intrínseca de dominar, sentirse competente y autoidentificarse.
- La dimensión **sociocultural y simbólica**.
- La dimensión **espiritual**.
- La dimensión **temporal**.

**Figura: modelo de adaptación a través de la ocupación (Reed y Sanderson)**

Tres círculos superpuestos: **entorno físico**, **entorno cultural** y **entorno psicobiológico**. En el centro: **adaptación personal a través de la ocupación**. De ahí salen tres grupos de destrezas: **conocimientos y destrezas cognitivas**, **destrezas y capacidades sensoriomotoras** y **destrezas intra e interpersonales**.

**Entorno (Larson, Wood y Clark, 2003)**

"Los contextos y situaciones que se manifiestan **en el exterior del individuo** y que suscitan respuestas de su parte." Atributos: **culturales, institucionales, físicos y sociales**.

**El sujeto (Reilly y Clarke Slagle, 1962)**

Un **todo integral inseparable del entorno** "que incorpora la espiritualidad, las experiencias sociales y culturales y los componentes observables del desempeño ocupacional".

**Desempeño ocupacional**

"La capacidad de **elegir, organizar y desempeñar** de manera satisfactoria ocupaciones **significativas definidas por la cultura y adecuadas a la edad** para el autocuidado, el disfrute de la vida y para contribuir con el entramado social y económico de la comunidad."

**La dimensión cultural**

El individuo usa las ocupaciones para interactuar con el ambiente en sus dimensiones **física, institucional, social y cultural**. La cultural abarca prácticas **étnicas, raciales, ceremoniales y rutinarias** basadas en costumbres y valores de cada grupo. La práctica siempre considera el aspecto cultural porque afecta el desempeño y la **calidad de vida**.

**PARA QUE LA INTERVENCIÓN SEA EFECTIVA**

El TO debe considerar el **significado que la persona le otorga** y comprender su medioambiente y su cultura. Wilcock (1998): "se necesita entender la cultura de la TO **en los términos propios del punto de vista del otro**". Rol: estrategias para la **integración y participación social** de grupos con discapacidad y vulnerabilidad, abordando contexto y desempeño. Cada ser humano es **único**.

## U3 Las AVD como instrumento de la CO

**EVALUACIÓN OCUPACIONAL (ROMERO Y MORUNO, 2003; AOTA, 2014)**

Proceso que **de manera sistemática adquiere información** que luego se **interpreta** según la naturaleza, condición y evolución del **estatus ocupacional** de la persona. Es necesaria para la futura intervención e incluye la **planificación y documentación** del proceso y sus resultados (Rodríguez Bailón, Navas Fernández y Garrido Cervera, 2018).

### 3.1 Los 8 objetivos de la evaluación de las AVD

| # | Objetivo | Qué implica |
|---|---|---|
| 1 | Recoger información sobre el **nivel actual de desempeño** y la **satisfacción** | Qué AVD hace y **cómo**: nivel de asistencia, eficiencia, eficacia y seguridad. Comparar con el **estado premórbido** y las expectativas socioculturales y personales (Moruno y Romero, 2006). Explorar la **satisfacción** según cultura y contexto, incluso necesidades íntimas. |
| 2 | Saber las **necesidades de participación** en AVD | Lo que **la persona** quiere potenciar, mejorar o cambiar; son distintas de las **limitaciones objetivas** que ve un profesional o un allegado. Perspectiva **centrada en la persona**: sus valores, creencias y experiencias son la fuente principal; el TO descubre lo que la persona busca solucionar. |
| 3 | Conocer las **limitaciones** y sus causas | Limitaciones **objetivas**: qué actividades, e incluso qué **partes** de la actividad, están comprometidas y **por qué**. |

| # | Objetivo | Qué implica |
|---|---|---|
| 4 | Analizar las **potencialidades** de la persona y el contexto | No solo la disfunción: también la **función ocupacional** y sus causas, para usarla en la intervención. |
| 5 | Conocer las **estrategias del propio usuario** | Muchas veces la persona y su entorno **ya respondieron** a sus problemas. Preguntar qué medidas tomó afianza su **sentido de control**. |
| 6 | Establecer un **diagnóstico ocupacional** | Con la entrevista inicial: **qué** disfunción ocurre (componente **descriptivo**) y **por qué** (componente **explicativo**), con los indicios que lo evidencian. |
| 7 | Examinar el **enfoque e intervenciones** más acordes | Con el estado inicial, limitaciones, necesidades, potencialidades y diagnóstico, se elige el enfoque que mejor funcione con **esa** persona. |
| 8 | **Evaluar los efectos** de la intervención | Sistematizar el estado inicial permite medir el **alcance** de la intervención y **visibilizar** los servicios de TO ante la persona y su familia. |

**CASO 1 DE LA LECTURA**

Una persona **no estima necesario cuidar su aseo**, pero el TO y su entorno lo ven como una limitación para su salud y sus vínculos. Se trabaja con el objetivo de **conocer las limitaciones que impiden la participación y sus posibles causas**, sin olvidar que las **necesidades personales** no son lo mismo que las limitaciones objetivas.

**CASO 2 DE LA LECTURA**

Un usuario **rígido en su rutina** de vestido, con problemas para inclinarse, probablemente **no acepte** de entrada un producto de apoyo (un **calzador de medias**). Objetivo: **examinar el enfoque y los tipos de intervención más acordes con la persona**.

## U4 La organización de las ocupaciones en el desarrollo humano

Investigaciones como las de **Jackson, Carlson, Mandel, Zemke y Clark (1998)** y **Vega, Buz y Bueno (2002)** muestran que la ocupación y la participación social tienen un **gran impacto en la salud mental y física** y en la calidad de vida.

**Ocupación como procedimiento o herramienta**

Medio para lograr el objetivo de **mejorar el bienestar físico y mental** (Aguilar, 2016).

VS

**Ocupación como contenido**

Es un contenido **en sí misma**: actividad **lúdica u ociosa** que sirve de entretenimiento.

**PRINCIPIOS BÁSICOS**

La participación en una ocupación es una **vía para obtener salud y bienestar social**; la ocupación se caracteriza por la **continuidad y el hábito**. Una sociedad que facilita el **equilibrio y la variedad** entre **tiempo libre, productividad y auto-mantenimiento** promueve seres humanos sanos (Aguilar, 2016).

**OJO CON LA PRODUCTIVIDAD**

La **valoración excesiva de la productividad** juega en contra. El tiempo libre no como pasatiempo sino como **alternativa creativa** que da placer y desarrollo personal reorganiza a la persona.

**Clark, Carlson, Jackson y Mandel (2003)**

Transmitir en la terapia la importancia de la ocupación para una **vida feliz y saludable**: si la persona se convence del poder de la actividad diaria, hay cambio positivo, **sensación de control** y habilidad para organizar su vida eligiendo sus ocupaciones.

**Corregidor, Moralejo y Ávila (2004)**

Con el conjunto de ocupaciones de la vida (trabajo, aseo, vestido, alimentación, cine, teatro, club, deporte) nos **adaptamos y dominamos el entorno**, respondemos a necesidades y expresamos intereses, valores y creencias: **identidad personal y social**.

**Wilcock (1998)**

El **bienestar psicológico y social** se vincula a la capacidad de desarrollar **ocupaciones socialmente valoradas**, de forma **equilibrada** entre productivas, de la vida diaria y lúdicas.

**SI LA OCUPACIÓN HACE BIEN…**

…la **reducción del nivel de actividad** por una dificultad que impida o dificulte hacerlas debe ser **objeto de atención**. La TO busca **enlentecer el deterioro** y conservar o recuperar capacidades, habilidades y destrezas que frenan la **independencia ocupacional**.

**Beneficios que debe buscar la TO (Moruno, 2002)**

- Promover el **aprendizaje y adquisición de habilidades** para auto-mantenimiento y autocuidado, educativas, productivas, de ocio y lúdicas.
- Favorecer la **participación e integración social** por adquisición, mantenimiento, mejora o recuperación del desempeño.
- Favorecer la participación social **modificando y adaptando** las ocupaciones o el entorno físico o social.

**Ocupación y desarrollo ontogenético**

**Reed y Sanderson (1999)**: participar en ocupaciones a lo largo del ciclo vital da **maduración sensorial, física y psicológica**, desarrollo social y emocional y aprendizaje de destrezas de adaptación. **Kielhofner (1995)**: el comportamiento ocupacional organiza las estructuras físicas y el desarrollo psicológico, afectivo y social; genera y mantiene cambios en **capacidades, creencias y disposiciones**.

### 4.1 La ocupación como método terapéutico, de promoción y de prevención

**Método terapéutico**
La TO es un medio para **desarrollar, mantener y recuperar** funciones psicológicas y corporales implicadas en las ocupaciones. Se usa la ocupación cuando contribuye al desarrollo de estructuras y funciones, relaciones, emociones y vínculos, y cuando **promueve su mantenimiento, restauración o recuperación**.

**Promoción y prevención (Moruno, 2002)**
Si la implicación en ocupaciones **significativas** (subjetiva, social y cultural) favorece el bienestar, la ocupación sirve para: promover **estilos de vida saludables** y prevenir enfermedades y déficits; y promover la **adquisición, mantenimiento y mejora** del bienestar físico, psicológico y social.

**JUBILACIÓN Y VEJEZ**
Si la **causalidad personal** no se mantuvo o no se exploraron intereses además de los laborales, la jubilación produce un **corte en la historia ocupacional** que puede afectar la salud y la longevidad. En ancianos con **demencia, depresión o ansiedad**, la alteración cognitiva y afectiva dificulta casi todas sus ocupaciones: la TO estudia sus ocupaciones, preocupaciones y condiciones de vida y orienta decisiones (Aguilar, 2016).

**RESUMEN DE LA LECTURA**
La ocupación favorece la **participación e integración social** mediante la adquisición, mantenimiento, mejora o recuperación del desempeño en **auto-mantenimiento y autocuidado, educación, productividad, ocio y juego**, e incide en la **salud y el bienestar** individual.

## U5 La CO y la TO hoy (I): teorías y metodologías

Toda intervención debe incluir las **teorías y conceptos** que sostienen el razonamiento: permiten **describir, explicar o predecir** los resultados. Las teorías pueden ser **personales o formales** y **tácitas o explícitas**; todas ayudan a razonar qué evaluar, cómo entender el problema, cómo intervenir y qué esperar. Hoy se exige **pensamiento crítico** de las teorías.

**Proposiciones**
Afirmaciones sobre **causas y efectos** entre características del mundo. Se pueden **evaluar** y, por lo tanto, **probar su falsedad**. La ciencia avanza desafiando y evaluando **hipótesis** (proposiciones sobre cómo funciona el mundo).

VS

**Supuestos**
Ideas que **creemos verdaderas**: se llega a una conclusión **sin evidencia definitiva**. **No pueden comprobarse** como verdaderas o falsas. Vienen de la **educación formal** o de la **experiencia personal**.

| Proposición (tabla 1) | Si... entonces... | Cómo comprobarla |
|---|---|---|
| **Practicar una habilidad en el contexto habitual da mayor destreza a largo plazo.** | Si se practica en el contexto natural, **entonces** se logra más destreza que en un contexto simulado. | Comparación controlada de la transferencia de una habilidad aprendida en contexto típico vs. **laboratorio**. |
| **El movimiento se organiza distinto al alcanzar un objeto deseado que al alcanzar un punto en el espacio.** | Si intenta alcanzar un objeto, **entonces** organiza el movimiento distinto que hacia un punto. | Análisis **cinematográfico** de los movimientos de la misma persona en dos condiciones. |

| Tipo de suposición (tabla 2) | Ejemplo en una teoría formal | Ejemplo en una teoría personal |
|---|---|---|
| **Sobre las causas: las personas controlan su conducta** | La conducta está dirigida por el **compromiso con objetivos personales**. | "Si realmente quisiera, podría cambiar ese mal hábito." |
| **Sobre la naturaleza de la persona: conocen e informan con exactitud sus motivos** | La información de los **informes personales** refleja con precisión las causas de la conducta. | "Una vez que haya hablado con ella tendremos una idea mucho más precisa de lo que la condujo a hacer eso." |
| **Sobre el desarrollo humano: hay una secuencia universal y óptima** | No seguir una secuencia estandarizada implica un **funcionamiento inferior al óptimo**. | "Si no nos centramos primero en sus habilidades auxiliares, siempre será menos eficaz." |
| **Sobre el conocimiento y el aprendizaje: la esencia es adquirir información** | La **falta de información** explica por qué las personas actúan de forma ineficaz. | "Muchos padres no dan las experiencias adecuadas: ofrezcamos una presentación sobre desarrollo motor típico." |

**Razonamiento tácito**
**Implícito**, basado en información o experiencias que **no podemos expresar con el lenguaje**. Los profesionales lo usan para captar matices sutiles de la intervención.

**Razonamiento explícito**
Hay que **trasladar lo tácito a lo explícito** para poder describir cómo pensamos de manera **lógica y avalada por la ciencia**.

### 5.1 Las teorías según su especificidad

Teoría = principio general o conjunto de principios aceptables que explican fenómenos. Se ubican en un espectro según su **grado de especificidad**.

**Teorías generales**
Modelo que explica una serie de hallazgos (**Whyte, 2006**); sistematiza lo observable, **focaliza observaciones** y ayuda a decidir; especifica la relación entre conceptos. En TO se usan la **teoría ecológica** y la de **sistemas**: relación transaccional **mente-cuerpo-entorno**, asumiendo un **impulso innato** a la exploración y la competencia. Las **sociológicas** agregan que la competencia se adquiere por la **retroalimentación del entorno**. Guían a observar **persona, entorno, ocupación** y sus interacciones.

**Teorías individuales**
Hipótesis basadas en teorías generales que describen **relaciones causales específicas**: identifican causas de un problema y proponen un mecanismo por el que la intervención produce el **cambio terapéutico**. Permiten controlar o modificar un fenómeno y fundamentan las teorías terapéuticas.

**Bronfenbrenner (1979)**
Teoría **ecológica**: la biología y las interacciones con un entorno cambiante son fundamentales para el desarrollo; los factores sociales lo **fomentan o inhiben**.

**Gibson (1979)**
**Potencialidad**: la percepción de la relación entre los objetos del entorno y las propias capacidades es lo que **habilita la acción**.

**Lawton (1986)**
**Presión**: las demandas del entorno o de las tareas influyen sobre el desempeño humano.

**⇆ TEORÍA TERAPÉUTICA VS. TEORÍA PARA EL TRATAMIENTO**
**Terapéutica**: estrecha las posibilidades de cambio y especifica **cómo actúa** una intervención: su **mecanismo de acción**. **Para el tratamiento**: explica el **desarrollo del cambio** y las **condiciones** bajo las cuales se logran los resultados.

**⚠ LAS TEORÍAS CLÍNICAS CAMBIAN**
Nacen de una observación que las explicaciones existentes no aclaran, y se basan en el conocimiento disponible **en ese momento**. Con más evidencia, las proposiciones se vuelven más exactas y la teoría **necesita modificarse**.

## U6 La CO y la TO hoy (II): orientaciones y modelos

### 6.1 CO-OP: orientación cognitiva al desempeño ocupacional cotidiano

**¿QUÉ ES LA CO-OP?**
Intervención **metacognitiva, centrada en el cliente y basada en el desempeño**. Combina los principios del **aprendizaje motor** con teorías sobre los **procesos cognitivos** y el **establecimiento de objetivos**. Objetivo: enseñar a los niños, mediante un proceso guiado, a usar **estrategias** para adquirir habilidades.

**¿Por qué se creó?**
Por la **falta de generalización** de lo aprendido. Las intervenciones para niños con dificultades motoras **leves a moderadas** apuntaban a las **deficiencias subyacentes** (Mandich, Polatajko, Macnab y Miller, 2001); se buscó un abordaje metacognitivo individualizado.

**Objetivo propio**
el niño fija sus metas: **Bandura (1997)** vio que así se sienten más seguros para actuar

→

**Preguntas guiadas**
estrategia global según la fórmula de **Luria (1976)**: el entorno se estructura con preguntas

→

**Reflexionar y elegir estrategia**
advertir su desempeño e **identificar una estrategia útil**

→

**Aplicar y generalizar**
usarla en **otras situaciones**; la práctica también es mecanismo de acción

Suposición de la CO-OP: **participar con éxito en ocupaciones es fundamental para la salud y el bienestar**. El proceso es dinámico y la mayor parte del tiempo se dedica a **reflexionar sobre el desempeño**.

### 6.2 Abordaje de TO orientado a la tarea

**Occupational Therapy Task-Oriented Approach**
Desarrollado por **Virgil Mathiowetz y Julie Bass-Haugen (1994)** para personas que tuvieron un **accidente cerebrovascular**. Toma de teorías generales: un modelo **sistémico del control motor**, un abordaje **ecológico de la percepción** y la teoría de los **sistemas de acción y dinámicos**.

**SUPOSICIÓN CENTRAL**
El movimiento **se organiza en torno a un objeto** y recibe información del entorno: **emerge de la interacción de varios sistemas**, y cada uno contribuye al control motor. Luego se sumó el **desempeño del rol** (**Trombly, 1995**): para participar satisfactoriamente en un rol, la persona debe poder hacer las **tareas y actividades que lo constituyen**, según su propia opinión.

### 6.3 Los modelos ecológicos (década de 1990)

**Ecología del desempeño humano**
Agrega un **entorno temporal** y habla de **tarea**.

**Persona-entorno-desempeño ocupacional**
Desarrollado de forma independiente en la misma década.

**Persona-entorno-ocupación**
Desarrollado de forma independiente en la misma década.

**LO QUE COMPARTEN**

Los tres destacan el **entorno**. El **desempeño ocupacional** es el interés primario del TO y está determinado por la **persona, el entorno y la ocupación**. Se diferencian en cómo definen esos conceptos, sus componentes y estructuras. Se basan en la **ciencia social** y describen la relación **persona-entorno**.

### Herencia: Bronfenbrenner (1979)

Influencia de los factores sociales en el desarrollo: el individuo en el centro de un sistema formado por **familia, amigos, comunidades e instituciones**, que aumentan o inhiben el desarrollo.

### Herencia: Gibson (1979)

**Potencialidad** en el ambiente físico: percibimos los objetos con características que llevan a una acción o significado; **no pensamos conscientemente** en ellas, pero la percepción define cómo interactuamos.

### Herencia: Lawton (1985)

**Presión ambiental**: las demandas del entorno; el comportamiento y el estado emocional se **ajustan y adaptan** a esa presión.

| Concepto | Definición en los modelos ecológicos |
|---|---|
| **Persona** | Visión **holística**: mente, cuerpo y espíritu. Variables: **valores e intereses** (qué es importante y significativo), **habilidades y capacidades** (cognitivas, sociales, emocionales, sensoriomotoras) y **experiencia de vida** (historia y narrativa). Influye en el entorno y es influida por él. |
| **Entorno** | Donde ocurre el desempeño: componentes **físicos** (lo tangible, construido y natural), **culturales** (valores, creencias y costumbres compartidas; etnia, religión, identidad nacional, sin limitarse a ellas) y **sociales** (capas: relaciones estrechas, grupos sociales y laborales, sistemas políticos y económicos). En el modelo de ecología, también **temporal**. |
| **Tarea** | **Representaciones objetivas** de todas las actividades posibles; unidades básicas con un **propósito** reconocido por quien las realiza; combinadas dan acciones con un propósito común. |

## 6.4 Tipos de intervención

### Establecer / restablecer

Sobre la **persona**: desarrollar o mejorar habilidades y capacidades para que pueda hacer las tareas.

### Adaptar / modificar

Cambian el **entorno o la tarea** para mejorar el desempeño.

### Alterar

**No modifican** tarea ni entorno: ajustan las acciones sobre el entorno **existente**.

### Prevención

Cambian el curso ante un resultado negativo previsto, **antes** de que aparezca el problema.

### Crear

Promueven el desempeño a nivel **contextual**, enriqueciéndolo.

# U7 La CO y la TO hoy (III): MOHO, adaptación ocupacional y transdisciplina

**MODELO DE LA OCUPACIÓN HUMANA (MOHO)**

Práctica **centrada en la ocupación**, **dirigida por la teoría**, **centrada en el cliente** y **basada en la evidencia**. Guía para pensar al cliente y la terapia: recoger información, conocer fortalezas y limitaciones y elegir el curso de la terapia. Es el modelo basado en la ocupación **de mayor uso internacional**.

### Trabaja 4 conceptos

1. La **motivación** en la ocupación.
2. Los **patrones de rutina**.
3. La naturaleza del **desempeño calificado**.
4. La influencia del **entorno**.

### Volición

Proceso por el que nos **motivamos y elegimos** actividades, en un ciclo de oportunidades. Pensamientos y sentimientos: **causalidad personal** (cuán capaz y eficaz me siento), **valores** (qué considero importante) e **intereses** (qué disfruto).

### Habituación

Organizamos las acciones en **patrones o rutinas** guiados por **hábitos** (maneras aprendidas y automáticas de hacer) y **roles** (dan identidad, responsabilidades y obligaciones).

### Capacidad de desempeño

Las **habilidades físicas y mentales** subyacentes y cómo se usan y **perciben** durante el desempeño.

### Entorno en el MOHO

Toda ocupación surge de la interacción entre lo **interno** de la persona y el entorno físico y social. Es el conjunto de aspectos **físicos, sociales, culturales, económicos y políticos** que afectan la motivación, la organización y el desempeño. Dimensiones: **objetos** que usamos · **espacios** donde actuamos · **tareas** disponibles o esperadas (con normas sociales) · **grupos sociales** · **fuerzas culturales, políticas y económicas**.

### Dimensiones del hacer

**1. Participación ocupacional**: participar en AVD, trabajo o recreación del contexto sociocultural, deseadas o necesarias para el bienestar.
**2. Desempeño ocupacional**: realizar una **tarea** vinculada a un área importante de la vida.
**3. Habilidad ocupacional**: durante el desempeño, buscar, manipular y secuenciar objetos: acciones con un propósito.

**NO CONFUNDIR**

De lo más amplio a lo más concreto: **participación** (áreas de la vida) → **desempeño** (tareas) → **habilidad** (acciones con objetos). Y no mezcles las 3 dimensiones del hacer con los 3 componentes de la persona (**volición, habituación, capacidad de desempeño**).

### 7.1 Modelo de la adaptación ocupacional (Schkade y Schultz, 1992)

Integra dos conceptos vigentes en la TO: **integración y ocupación** (la ocupación como paradigma de la TO). La TO supone que quienes logran más funcionalidad son los que **se adaptan mejor**; esta teoría plantea que **la adaptación es lo que da mayor funcionalidad**.

| # | Los 6 supuestos que relacionan desempeño ocupacional y adaptación |
|---|---|
| 1 | La **competencia en la ocupación** es un proceso de adaptación a demandas internas y externas que **dura toda la vida**. |
| 2 | Las demandas para el desempeño surgen naturalmente de los **roles ocupacionales** y del contexto. |
| 3 | La **disfunción** ocurre porque la capacidad de adaptación sufrió una **sobreexigencia** y las demandas no se ejecutan satisfactoriamente. |
| 4 | La capacidad de adaptación puede comprometerse por **deficiencias, discapacidades físicas o emocionales y estrés**. |
| 5 | **A mayor disfunción, mayor demanda** de cambios en el proceso de adaptación. |
| 6 | El **éxito** en el desempeño resulta directamente de la capacidad de adaptación con suficiente **pericia** para satisfacer las necesidades propias y de otros. |

**Deseo de pericia**
factor interno **constante** e innato (hasta a nivel celular)

+

**Demanda de pericia**
del **entorno ocupacional**

→

**Presión por lograr la pericia**
**centro del modelo**: da lugar al **desafío ocupacional**

→

**Respuesta adaptativa interna**
la persona responde a la situación desafiante

→

**Respuesta ocupacional**
**observable**: acción o comportamiento

**La persona en el modelo**
Factores internos: el **deseo de pericia o dominio** (la búsqueda de dominio del entorno es **innata**) y los sistemas **cognitivos, sensorio-motores y psicosociales**, afectados por influencias genéticas, biológicas y fenomenológicas. Todas las opciones son **holísticas**: involucran todos los sistemas.

**LINEAL EN EL PAPEL, NO EN LA REALIDAD**
El modelo se presenta en **formato lineal** para organizar fenómenos muy interactivos, pero el proceso real de adaptación es **complejo, aleatorio y no lineal**.

**La transdisciplina**
Implica una **conciencia histórica y reflexiva** del mundo. La mirada epistemológica muestra dónde se alberga el **ser y el hacer** de una disciplina rodeada de otras que la complementan: cómo modifico el mundo y **cómo soy modificado** por él.

**EL CONOCIMIENTO DE LA TO VA "AL REVÉS"**
La TO se sustenta en las **ciencias sociales**. Su conocimiento se construyó de forma **inversa a las ciencias duras**: **nace del hacer** y después desarrolla el **saber**, vinculándose con las **ciencias aplicadas**.

## U8 La CO y la TO hoy (IV): fortalezas y debilidades de la investigación

### 8.1 Supuestos epistemológicos

**EPISTEMOLOGÍA**
Del griego **epistḗmē** (conocimiento, saber) + **logos** (teoría, estudio): el **estudio del conocimiento**. Para **Platón**, "verdadero conocimiento". Estudia la naturaleza del conocimiento: su procedencia, cómo se concibe, qué es verdad, cómo se conoce la realidad, su **historicidad** (cómo ocurrieron los hechos, cómo se gestó la idea, quién y cómo lo descubrió). Suele definirse como la parte de la ciencia de la **teoría del conocimiento**, que conoce las cosas en su **esencia y sus causas**.

**Definiciones para asociar**
**Piaget**: el estudio del **pasaje de estados de menor conocimiento a estados de conocimiento más avanzado**; rama de la filosofía que investiga fundamentos, límites, métodos y validez del conocimiento.
**Otros autores**: recorrido por la historia del sujeto en la construcción del conocimiento científico; estudia la **génesis de las ciencias** (métodos experimentales o hermenéuticos).
**Ricci (1999)**: el punto de vista desde el que me relaciono con las cosas; un **mirador u observatorio** que no está fuera de la realidad sino que **contribuye a constituirla** (participación activa).

**En la CO**
Buscar respuestas a las preguntas de la disciplina: ¿cuándo y por qué nació la TO? ¿Qué hechos influyeron? ¿Qué logros se observaron? ¿Hay datos que avalen sus resultados? → aproximación al **método científico**.

**El mundo de la vida**
El conocimiento se basa en vivencias de la **cotidianidad**, en la relación **sujeto-objeto-sujeto**. Actitudes estables que expresan identificación con grupos (seguridad y sentido); lugar entre **hablante y oyente** para ordenar discrepancias y llegar a acuerdos.

**Pensamiento reflexivo**
La epistemología necesita pensamiento **crítico** del conocimiento frente a sí mismo, sus pares e impares (otros) y su mundo (lo otro). Lo "científico" debe **depurarse continuamente** en procesos subjetivos e intersubjetivos.

**⚠ SALUD, ENFERMEDAD Y DUELO**

En el quehacer del TO es imposible abstraerse de la dualidad **salud/enfermedad/duelo**. Una **discapacidad adquirida** genera un cuestionamiento constante del sentido de la existencia: una filosofía centrada en la **subjetividad**, un pensamiento **existencial**.

**SALUD DESDE LA TO (SANZ VALER Y RUBIO ORTEGA, 2011)**

Un **equilibrio de bienestar físico, mental y social** alcanzado mediante **ocupaciones significativas** individual y socialmente valoradas. La ocupación es parte integral de la experiencia de salud o enfermedad: los haceres estimularon y entusiasmaron a unos y aburrieron, estresaron, alienaron o deprimieron a otros (Wilcock).

## 8.2 Supuestos paradigmáticos

**1.ª capa**
**conocimientos relacionados** (sociología, psicología, medicina...)

→

**2.ª capa**
**modelos conceptuales**

→

**3.ª capa: paradigmas**
"conjunto de **creencias, valores y técnicas compartidos** por una comunidad científica" (Polonio et al., 2001)

### Thomas Kuhn

Concepto de **paradigma** con visión **historicista**: la explicación del mundo se basa en **creencias y valores consensuados**. Uno de los primeros en ver la ciencia como actividad de una **comunidad** (no el científico individual frente a un problema individual). Los científicos mantienen **consensos no siempre explícitos** sobre qué problemas importan, qué preguntas hacer, cómo responderlas y de qué está hecha la realidad.

### ¿Qué es un paradigma?

Conjunto de prácticas que definen una disciplina científica en un **período determinado**: **conceptos teóricos centrales**, un **punto de vista** y **valores** compartidos por una comunidad, más las **soluciones concretas** a los problemas de la ciencia, expresadas en **modelos**.

**⚠ CRISIS PARADIGMÁTICA**

Según varios autores, la TO está en **crisis paradigmática**: deja lo centrado en la ocupación y va hacia una **noción crítica de la realidad**, donde la ocupación define al ser humano y el ambiente puede **permitir o restringir** que sea en la sociedad.

### Humberto Maturana

La ciencia es el **hacer conocimiento**: construcción de saberes que, desde la investigación, desarrolla las disciplinas.

### Laura Rueda (2007)

La CO es un **eje fundamental de la TO**: estructura el propósito y desarrollo de toda actividad terapéutica y enmarca sus objetivos; incluye el aprendizaje y entrenamiento para adquirir **habilidades y costumbres**.

**CIERRE DE LA MATERIA (MERINO, ACEVEDO Y ALVARADO, 2020)**

Etapas: primeras reflexiones sobre la ocupación → necesidad de una ciencia que estudie su efecto terapéutico → **fundación formal de la CO en 1980**. Es **ciencia** (recolección sistemática de datos) y **multiprofesional** (afín a antropología, psicología y sociología).

## Para consultar: autores y conceptos clave

| Autor | Asociá con... | Concepto | En una línea |
|---|---|---|---|
| **Wilcock (1998)** | Ser, hacer y llegar a ser; entender la cultura del otro | Sujeto ocupacional | Lo que permite comprender forma, función y significado |
| **Geertz (1989)** | Cultura como sistema de concepciones heredadas | Derechos ocupacionales | Reducen determinantes sociales de la salud |
| **Corral Bergantiños et al. (2010)** | Ocupación y cultura; 6 dimensiones | Diagnóstico ocupacional | Componente descriptivo + explicativo |
| **Reed y Sanderson** | Adaptación a través de la ocupación; desarrollo ontogenético | Necesidades vs. limitaciones | Lo que quiere la persona vs. lo objetivo |
| **Larson, Wood y Clark (2003)** | Definición de entorno | Proposición | Causa-efecto, falsable |
| **Reilly y Clarke Slagle (1962)** | Desempeño ocupacional; sujeto integral | Supuesto | Creído verdadero, no comprobable |
| **Romero y Moruno · AOTA** | Evaluación ocupacional | Tácito / explícito | No expresable / lógico y comunicable |
| **Aguilar (2016)** | Ocupación herramienta vs. contenido; equilibrio | Teoría terapéutica | Mecanismo de acción |
| **Moruno (2002)** | Beneficios de la TO; promoción y prevención | CO-OP | Metacognitiva, centrada en el cliente, niños |
| **Bronfenbrenner · Gibson · Lawton** | Ecológica · potencialidad · presión | Volición | Causalidad personal, valores, intereses |
| **Mandich, Polatajko et al.** | CO-OP | Habituación | Hábitos y roles |

| Autor | Asociá con... | Concepto | En una línea |
|---|---|---|---|
| **Bandura · Luria** | Objetivos propios · preguntas guiadas | Dimensiones del hacer | Participación, desempeño, habilidad |
| **Mathiowetz y Bass-Haugen (1994)** | Abordaje orientado a la tarea (ACV) | Presión por la pericia | Centro del modelo de adaptación |
| **Trombly (1995)** | Desempeño del rol | Intervención “alterar” | Sin cambiar tarea ni entorno |
| **Schkade y Schultz (1992)** | Adaptación ocupacional | Transdisciplina | Conciencia histórica y reflexiva |
| **Kuhn · Polonio** | Paradigma | Crisis paradigmática | Hacia una noción crítica de la realidad |
| **Piaget · Ricci** | Epistemología | Historicidad | Contextualizar cómo surgió un saber |

## Preguntas de desarrollo con respuesta modelo

### ¿Por qué la cultura es central en la intervención del TO?

Porque la ocupación es **cultural**: sus patrones son aprendidos y la cultura se **internaliza** (valores, intereses, roles, hábitos). Una actividad cambia de significado según la cultura. Para intervenir hay que comprender el **significado para la persona** y su entorno, “en los términos del otro” (Wilcock, 1998).

### Nombrá y explicá 4 objetivos de la evaluación de AVD.

Ej.: **desempeño actual y satisfacción** (cómo hace sus AVD vs. estado premórbido); **necesidades** (lo que la persona quiere cambiar); **estrategias propias** (afianza el sentido de control); **diagnóstico ocupacional** (qué disfunción y por qué). También: limitaciones, potencialidades, enfoque y efectos.

### Diferenciá proposición y supuesto con un ejemplo.

**Proposición**: afirmación causa-efecto evaluable y falsable (practicar en el contexto natural da más destreza; se compara con laboratorio). **Supuesto**: idea creída verdadera sin evidencia definitiva (“si quisiera, podría cambiar ese hábito”).

### Explicá la volición, la habituación y la capacidad de desempeño del MOHO.

**Volición**: motivación y elección (causalidad personal, valores, intereses). **Habituación**: patrones y rutinas con hábitos y roles. **Capacidad de desempeño**: habilidades físicas y mentales y cómo se perciben al hacer.

### Describí el proceso de adaptación ocupacional.

El **deseo de pericia** (innato) interactúa con la **demanda de pericia** del entorno; surge la **presión por lograr la pericia** (centro), que genera el **desafío ocupacional**; hay una respuesta adaptativa interna y una **respuesta ocupacional observable**. Lineal en el papel, no lineal en la realidad.

### ¿Qué es un paradigma y por qué se habla de crisis en la TO?

Conjunto de creencias, valores y técnicas compartidos por una comunidad científica (Polonio; Kuhn) en un período. Hay crisis porque la TO pasa de lo centrado en la ocupación a una **noción crítica de la realidad**, donde el ambiente puede permitir o restringir a la persona.

### Compará la CO-OP con el abordaje orientado a la tarea.

**CO-OP**: niños con dificultades motoras leves a moderadas; metacognitiva, centrada en el cliente, el niño fija objetivos (Bandura) y descubre estrategias con preguntas guiadas (Luria); busca generalizar. **Orientado a la tarea** (Mathiowetz y Bass-Haugen, 1994): personas con ACV; el movimiento emerge de la interacción de sistemas y se organiza en torno a un objeto; Trombly suma el desempeño del rol.

### Aplicá los 5 tipos de intervención a un caso (persona mayor que ya no puede cocinar).

**Establecer**: entrenar fuerza y coordinación. **Adaptar**: utensilios con mango engrosado o cocina a otra altura. **Alterar**: reorganizar cómo usa la cocina que ya tiene. **Prevención**: pautas para evitar caídas antes de que ocurran. **Crear**: un taller comunitario de cocina que enriquezca el contexto.

### ¿Por qué la ocupación sirve como método de promoción y prevención?

Porque la implicación en ocupaciones **significativas** favorece el bienestar psicológico (Moruno, 2002): promueve estilos de vida saludables, previene enfermedades y déficits, y mejora el bienestar físico, psicológico y social. Ej.: preparar la jubilación explorando otros intereses.

### ¿Qué es la epistemología y por qué le importa a la TO?

Estudio del conocimiento: su origen, validez, métodos e historicidad (Piaget: pasar de menor a mayor conocimiento; Ricci: un mirador que participa de la realidad). A la TO le sirve para revisar críticamente su saber, que nació **del hacer**, y entender sus paradigmas.

## R Preparación para el parcial

**1 ¿Es evaluable?**
Si se puede poner a prueba y falsar, es proposición; si se cree sin prueba, es supuesto.

**2 ¿Qué se cambia?**
Persona = establecer. Tarea o entorno = adaptar. Nada = alterar. Antes del problema = prevenir. Contexto = crear.

**3 Ubicá al autor en el modelo**
Bronfenbrenner, Gibson y Lawton son la herencia de los modelos ecológicos.

**4 Caso de AVD**
Leé qué hace el TO en el caso y elegí cuál de los 8 objetivos de evaluación está cumpliendo.

**5 MOHO en capas**
Persona (volición, habituación, capacidad) ≠ dimensiones del hacer (participación, desempeño, habilidad).

**6 Población del abordaje**
CO-OP = niños con dificultades motoras. Orientado a la tarea = ACV.

## ! Errores frecuentes

- ⊗ *"Los supuestos se pueden probar falsos."* → Eso son las **proposiciones**.
- ⊗ *"Necesidades = limitaciones objetivas."* → Las necesidades las define **la persona**.
- ⊗ *"La intervención de alterar modifica el entorno."* → Eso es **adaptar/modificar**; alterar ajusta sin cambiar.
- ⊗ *"Gibson habló de presión ambiental."* → Gibson = **potencialidad**; Lawton = presión.
- ⊗ *"El centro del modelo de adaptación es el deseo de pericia."* → Es la **presión por lograr la pericia**.
- ⊗ *"La habituación incluye los intereses."* → Intereses son de la **volición**; habituación = hábitos y roles.
- ⊗ *"La TO construyó su saber como las ciencias duras."* → Al revés: **nace del hacer**.
- ⊗ *"La ocupación como contenido es una herramienta."* → Como contenido es un **fin en sí misma** (lúdica u ociosa).

## ☆ Tarjetas de memoria rápida

**Wilcock 1998**
Ser, hacer, llegar a ser.

**Atributos del entorno**
Culturales, institucionales, físicos, sociales.

**6 dimensiones**
Acto, contexto, psicológica, sociocultural-simbólica, espiritual, temporal.

**Reed y Sanderson**
Entorno físico, cultural, psicobiológico.

**Diagnóstico**
Descriptivo (qué) + explicativo (por qué).

**Equilibrio (Aguilar)**
Tiempo libre, productividad, auto-mantenimiento.

**4 suposiciones**
Causas, persona, desarrollo, conocimiento.

**Teorías**
Generales → individuales → terapéuticas → tratamiento.

**Modelos ecológicos**
Ecología del desempeño, P-E-desempeño, P-E-O.

**5 intervenciones**
Establecer, adaptar, alterar, prevenir, crear.

**MOHO: 4 conceptos**
Motivación, rutina, desempeño calificado, entorno.

**Entorno MOHO**
Objetos, espacios, tareas, grupos, fuerzas.

**Adaptación**
Deseo + demanda → presión → respuesta.

**Persona (adaptación)**
Cognitiva, sensoriomotora, psicosocial.

**3 capas**
Conocimientos, modelos, paradigmas.

**Epistemología**
Episteme + logos: estudio del conocimiento.

## ⇆ Tabla anti-confusiones

| Si la pregunta menciona... | Pensá en... | No confundir con... |
|---|---|---|
| **Sistema de concepciones heredadas** | **Cultura (Geertz)** | Sociedad |
| **Elegir, organizar y desempeñar** | **Desempeño ocupacional** | Participación ocupacional |
| **Lo que la persona quiere cambiar** | **Necesidades** | Limitaciones objetivas |
| **Percibir qué acción permite un objeto** | **Potencialidad (Gibson)** | Presión (Lawton) |
| **Cómo actúa una intervención** | **Teoría terapéutica** | Teoría para el tratamiento |
| **Metacognitiva, niños, Luria** | **CO-OP** | Orientado a la tarea |
| **Cuán capaz me siento** | **Causalidad personal** | Valores / intereses |
| **Buscar, manipular y secuenciar objetos** | **Habilidad ocupacional** | Desempeño ocupacional |
| **Creencias, valores y técnicas compartidos** | **Paradigma** | Modelo conceptual |

## S Simulacro: 30 preguntas multiple choice

Una sola respuesta correcta por pregunta. Resolvelo sin mirar la clave (al final).

**1** **Según Wilcock (1998), la ocupación es una síntesis de:**

Ⓐ Forma, función y significado.
Ⓑ Volición, habituación y desempeño.
Ⓒ Ser, hacer y llegar a ser.
Ⓓ Organismo, actividad y participación.

**2** **La premisa de la CO es que conocer la forma, la función y el significado de las ocupaciones permite comprender al hombre como:**

Ⓐ Un “sujeto ocupacional”.
Ⓑ Un organismo biológico.
Ⓒ Un paciente a rehabilitar.
Ⓓ Un consumidor de servicios.

**3** **Para Geertz (1989), la cultura es:**

Ⓐ El conjunto de personas que viven de una manera determinada.
Ⓑ Solo las prácticas religiosas de un grupo.
Ⓒ El entorno físico construido.
Ⓓ Un sistema de concepciones heredadas expresado en formas simbólicas.

**4** **Según Larson, Wood y Clark (2003), el entorno se clarifica por sus atributos:**

Ⓐ Biológicos, psicológicos y espirituales.
Ⓑ Culturales, institucionales, físicos y sociales.
Ⓒ Temporales y económicos únicamente.
Ⓓ Individuales y familiares.

**5** **“La capacidad de elegir, organizar y desempeñar de manera satisfactoria ocupaciones significativas definidas por la cultura y adecuadas a la edad” define:**

Ⓐ El desempeño ocupacional.
Ⓑ La volición.
Ⓒ La habilidad ocupacional.
Ⓓ La forma ocupacional.

**6** **En el modelo de Reed y Sanderson, en el centro de los tres entornos (físico, cultural y psicobiológico) está:**

Ⓐ El diagnóstico ocupacional.
Ⓑ La presión ambiental.
Ⓒ La adaptación personal a través de la ocupación.
Ⓓ La causalidad personal.

**7** **El proceso que sistemáticamente adquiere información para interpretarla según la naturaleza, condición y evolución del estatus ocupacional es:**

Ⓐ El rediseño de vida.
Ⓑ La evaluación ocupacional.
Ⓒ La intervención de crear.
Ⓓ El razonamiento tácito.

**8** **El diagnóstico ocupacional tiene un componente:**

Ⓐ Solo descriptivo.
Ⓑ Predictivo y estadístico.
Ⓒ Exclusivamente médico.
Ⓓ Descriptivo (qué disfunción ocurre) y explicativo (por qué ocurre).

**9** **Preguntar al usuario qué medidas tomó por su cuenta para adaptarse, lo que afianza su sentido de control, corresponde al objetivo de:**

Ⓐ Evaluar los efectos de la intervención.
Ⓑ Establecer un diagnóstico.
Ⓒ Conocer las estrategias usadas por el propio usuario.
Ⓓ Conocer las limitaciones objetivas.

**10** **Para Aguilar (2016), la ocupación “como contenido” es:**

Ⓐ Una actividad lúdica u ociosa en sí misma, que sirve de entretenimiento.
Ⓑ Un procedimiento para mejorar el bienestar.
Ⓒ Una evaluación estandarizada.
Ⓓ Un rol productivo.

**11** **Según Aguilar (2016), una sociedad que promueve seres humanos sanos es la que:**

Ⓐ Valora sobre todo la productividad.
Ⓑ Elimina el tiempo libre.
Ⓒ Prioriza el autocuidado sobre todo lo demás.
Ⓓ Facilita el equilibrio y la variedad entre tiempo libre, productividad y auto-mantenimiento.

**12** **¿Por qué la jubilación puede afectar la salud y la longevidad?**

Ⓐ Porque aumenta la presión ambiental.
Ⓑ Porque, si no se mantuvo la causalidad personal ni se exploraron otros intereses, corta la historia ocupacional.
Ⓒ Porque impide el razonamiento explícito.
Ⓓ Porque elimina las AVD básicas.

**13** **Las afirmaciones sobre causas y efectos que pueden evaluarse y probarse falsas son:**

Ⓐ Proposiciones.
Ⓑ Supuestos.
Ⓒ Paradigmas.
Ⓓ Creencias tácitas.

**14** **"Si realmente quisiera, podría cambiar ese mal hábito" es un ejemplo de:**

Ⓐ Una proposición comprobable.
Ⓑ Una suposición sobre el desarrollo humano.
Ⓒ Una suposición sobre las causas, en una teoría personal.
Ⓓ Un razonamiento explícito.

**15** **El razonamiento tácito se caracteriza por:**

Ⓐ Ser siempre lógico y avalado por la ciencia.
Ⓑ Estar escrito en protocolos.
Ⓒ Poder probarse falso.
Ⓓ Ser implícito, basado en experiencias que no podemos expresar con el lenguaje.

**16** **El concepto de "potencialidad" (la percepción de la relación entre objetos y capacidades habilita la acción) es de:**

Ⓐ Lawton.
Ⓑ Gibson.
Ⓒ Bronfenbrenner.
Ⓓ Trombly.

**17** **Lawton propone el concepto de:**

Ⓐ Teoría ecológica del desarrollo.
Ⓑ Desempeño del rol.
Ⓒ Presión ambiental: las demandas del entorno influyen en el desempeño.
Ⓓ Metacognición.

**18** **La teoría que especifica cómo actúa una intervención en particular (su mecanismo de acción) es la:**

Ⓐ Teoría terapéutica.
Ⓑ Teoría para el tratamiento.
Ⓒ Teoría general.
Ⓓ Teoría personal tácita.

**19** **La CO-OP es:**

Ⓐ Un tratamiento farmacológico.
Ⓑ Un modelo para personas con ACV.
Ⓒ Una evaluación de AVD.
Ⓓ Una intervención metacognitiva, centrada en el cliente y basada en el desempeño, para niños con dificultades motoras.

**20** **El abordaje de TO orientado a la tarea fue desarrollado por:**

Ⓐ Schkade y Schultz.
Ⓑ Mathiowetz y Bass-Haugen (1994), para personas con ACV.
Ⓒ Mandich y Polatajko.
Ⓓ Reed y Sanderson.

**21** **El aporte de Trombly (1995) al abordaje orientado a la tarea fue:**

Ⓐ Incluir el desempeño del rol: para participar en un rol hay que poder hacer sus tareas, según la persona.
Ⓑ El concepto de potencialidad.
Ⓒ La evaluación sensorial.
Ⓓ Los seis supuestos de la adaptación.

**22** **Una intervención que cambia el entorno o la tarea para mejorar el desempeño es de tipo:**

Ⓐ Establecer / restablecer.
Ⓑ Alterar.
Ⓒ Crear.
Ⓓ Adaptar / modificar.

**23** **Una intervención que se aplica antes de que el problema se desarrolle es de:**

Ⓐ Alterar.
Ⓑ Establecer.
Ⓒ Prevención.
Ⓓ Adaptar.

**24** **En el MOHO, la volición incluye:**

Ⓐ Hábitos y roles.
Ⓑ Causalidad personal, valores e intereses.
Ⓒ Objetos y espacios.
Ⓓ Habilidades físicas y mentales.

**25** **En el MOHO, la habituación se refiere a:**

Ⓐ La motivación para elegir actividades.
Ⓑ Las fuerzas políticas del entorno.
Ⓒ Las habilidades sensoriomotoras.
Ⓓ Organizar las acciones en patrones o rutinas guiados por hábitos y roles.

**26** **Cuando la persona realiza una tarea relacionada con un área importante de su vida, el MOHO habla de:**

Ⓐ Desempeño ocupacional.
Ⓑ Habilidad ocupacional.
Ⓒ Participación ocupacional.
Ⓓ Causalidad personal.

**27** **El modelo de la adaptación ocupacional fue propuesto por:**

Ⓐ Kielhofner y Burke.
Ⓑ Mathiowetz y Bass-Haugen.
Ⓒ Schkade y Schultz (1992).
Ⓓ Bronfenbrenner.

**28** **El centro del modelo de adaptación ocupacional, que da lugar al desafío ocupacional, es:**

Ⓐ El deseo de pericia.
Ⓑ La presión por lograr la pericia.
Ⓒ La respuesta ocupacional observable.
Ⓓ El entorno físico.

**29** **“Conjunto de creencias, valores y técnicas compartidos por una comunidad científica” define:**

Ⓐ Un modelo conceptual.
Ⓑ Una proposición.
Ⓒ La transdisciplina.
Ⓓ Un paradigma.

**30** **Para Piaget, la epistemología es:**

Ⓐ El estudio del pasaje de estados de menor conocimiento a estados de conocimiento más avanzado.
Ⓑ El “verdadero conocimiento”.
Ⓒ Un mirador u observatorio de la realidad.
Ⓓ La ciencia que estudia la ocupación.

✎ TUS RESPUESTAS

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

## Clave de respuestas explicada

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 C | 2 A | 3 D | 4 B | 5 A | 6 C | 7 B | 8 D | 9 C | 10 A |
| 11 D | 12 B | 13 A | 14 C | 15 D | 16 B | 17 C | 18 A | 19 D | 20 B |
| 21 A | 22 D | 23 C | 24 B | 25 D | 26 A | 27 C | 28 B | 29 D | 30 A |

**1. C)** Wilcock: ser, hacer y llegar a ser. × A: objeto de la CO. B: MOHO. D: concepción biomédica.

**2. A)** La premisa lleva al "sujeto ocupacional". × B y C: miradas biomédicas. D: no aparece.

**3. D)** Definición textual de Geertz. × A: definición de sociedad. B y C: recortes.

**4. B)** Culturales, institucionales, físicos y sociales. × C: el temporal aparece en el modelo de ecología.

**5. A)** Definición de desempeño ocupacional (Reilly y Clarke Slagle). × B: motivación. C: acciones con objetos. D: Nelson.

**6. C)** En el centro: adaptación personal a través de la ocupación. × B: Lawton. D: MOHO.

**7. B)** Es la evaluación ocupacional (Romero y Moruno; AOTA). × A: programa preventivo. C: tipo de intervención.

**8. D)** Qué ocurre (descriptivo) y por qué (explicativo). × A: le falta el explicativo.

**9. C)** Estrategias del usuario sin intervención profesional. × A: al final del proceso. D: limitaciones objetivas.

**10. A)** Como contenido es un fin en sí mismo. × B: es la ocupación como procedimiento o herramienta.

**11. D)** Equilibrio y variedad entre las tres áreas. × A: la sobrevaloración de la productividad juega en contra.

**12. B)** Corte en la historia ocupacional. × A, C y D no los menciona la lectura.

**13. A)** Proposiciones: evaluables y falsables. × B: no se pueden comprobar.

**14. C)** Suposición sobre las causas (las personas controlan su conducta), teoría personal. × A: no se comprueba.

**15. D)** Tácito = implícito, difícil de expresar. × A: eso es el explícito. C: proposición.

**16. B)** Gibson: potencialidad. × A: presión. C: ecológica. D: rol.

**17. C)** Lawton: presión ambiental. × A: Bronfenbrenner. B: Trombly. D: CO-OP.

**18. A)** Teoría terapéutica = mecanismo de acción. × B: explica el desarrollo del cambio y sus condiciones.

**19. D)** CO-OP: metacognitiva, cliente, desempeño, niños. × B: es el abordaje orientado a la tarea.

**20. B)** Mathiowetz y Bass-Haugen, ACV. × A: adaptación. C: CO-OP. D: figura de adaptación.

**21. A)** Trombly sumó el desempeño del rol. × B: Gibson. D: Schkade y Schultz.

**22. D)** Adaptar/modificar cambia tarea o entorno. × A: sobre la persona. B: no cambia nada.

**23. C)** Prevención: antes del problema. × A, B y D actúan sobre lo existente.

**24. B)** Volición: causalidad personal, valores, intereses. × A: habituación. C: entorno. D: capacidad.

**25. D)** Habituación: patrones con hábitos y roles. × A: volición. C: capacidad de desempeño.

**26. A)** Desempeño = hacer una tarea de un área importante. × B: acciones con objetos. C: áreas amplias de la vida.

**27. C)** Schkade y Schultz (1992). × A: MOHO. B: tarea. D: herencia ecológica.

**28. B)** La presión por lograr la pericia es el centro. × A: es un factor constante. C: es el resultado.

**29. D)** Paradigma (Polonio; Kuhn). × A: es la 2.ª capa. C: conciencia histórica y reflexiva.

**30. A)** Definición de Piaget. × B: Platón. C: Ricci. D: es la CO.